Santé
Université de Paris

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Evolution des systèmes, acteurs et relations de soin

- *Responsables de l'UE : C. Lefève et M.-F. Mamzer*
- *Intervenante : Coline Periano, ATER Université Paris Cité*

Année universitaire 2026-2027

Introduction

Objectifs du cours :

- Comprendre comment les acteurs du soin se font face ou coopèrent au cours du temps.
- Comprendre comment l'évolution des pratiques médicales modifie l'environnement du soin.
- Connaître les grandes étapes de l'histoire de l'hôpital.
- Comprendre que le soin est toujours situé dans des espaces, régi par des connaissances scientifiques, des pratiques, mais aussi des réseaux d'acteurs, des contraintes et des impératifs économiques ou de santé publique.

Plan du cours

I. Histoire de la profession médicale et de son organisation

II. Histoire de l’hôpital et de son architecture

III. Histoire du rôle des patients dans le système de santé et la relation de soin.

I. Histoire de la profession médicale

A. Régulation interne de la profession :

Sur le temps long, le rôle du médecin ne change pas :

- Prévenir et traiter les maladies, maintenir la santé
- En étant expert de la prise en charge des maladies
- Grace à une formation théorique complétée par la pratique

Ce qui change avec le temps :

- La société, son économie et ses valeurs
- Les connaissances scientifiques
- Les moyens techniques

I. Histoire de la profession médicale

1. Dans l'Antiquité :

- Peu de médecins, et souvent ambulants
- Être médecin est un métier : forme de travail qualifié qui peut recouvrir des formes d'exercice différentes.
- Apprentissage auprès d'un maître.
- Pas de certification qualifiante
- Difficile de distinguer les imposteurs

I. Histoire de la profession médicale

2. Au Moyen-Age

- Naissance des universités de médecine : organisation plus formelle de la formation
- Contrôle de l'exercice par les facultés
- Naissance des corporations : communauté de métier, auto-organisation d'une profession.
- Renforce la régulation de la profession.
- Médecine ≠ Chirurgie :

- Médecine : discipline théorique et intellectuelle, enseignée à l'Université, basée sur des textes anciens
- Chirurgie : activité pratique, souvent réalisée par des artisans (moins respectés)

I. Histoire de la profession médicale

3. Après la Révolution française

- Les corporations disparaissent
- Proposition : instaurer un ordre professionnel pour encadrer les pratiques et lutter contre le charlatanisme.
- Au milieu du XIXe siècle : mise en place, dans chaque arrondissement ou département, d'un collège médical inscrivant les médecins sur un tableau et pouvant prononcer « admonestation (avertissement), réprimande, censure, radiation temporaire » et dans les cas extrêmes une radiation définitive.
- En 1945 (juste après la Seconde Guerre mondiale) : création de l'Ordre des médecins, dans un contexte de restructuration du système de santé : volonté de réguler l'exercice des professions de santé.

I. Histoire de la profession médicale

B. Entre les professions

1. Coopération entre les professionnels

- La régulation de la profession distingue les médecins, mais ça ne veut pas dire que les médecins travaillent seuls !
- Le personnel soignant que l'on appelle aujourd'hui « paramédical » s'est multiplié avec le temps.
- En 2017, en France, 2.23 millions de personnes exercent un métier dans le secteur de la santé. En 2025, plus de 230 000 sont médecins et presque 600 000 sont infirmiers ou infirmières.
- Cette coopération est essentielle mais difficile ! Défis à surmonter : communication, reconnaissance des rôles, formations, charge de travail.

I. Histoire de la profession médicale

2. Réorganisation entre les professions

- La formation change également et offre de nouvelles assises universitaires aux métiers de la santé : exemple, l'universitarisation de la maïeutique et de la profession infirmière ces dernières années + création d'un nouveau statut : les infirmiers de pratiques avancées (IPA).
- Réorganisations entre les professions qui s'expliquent par : spécialisation, transfert de compétences, création de nouveaux métiers.
- Certaines pratiques sont autorisées ou interdites avec le temps : exemple, les ostéopathes sont désormais considérés comme des professions de santé, alors qu'ils étaient interdits jusqu'à en 2002.

I. Histoire de la profession médicale

3. Une coopération essentielle mais difficile

- Coopération = collaboration entre différents professionnels de santé pour fournir des soins coordonnés et complets aux patients.
- Besoins accrus de coopération car : vieillissement de la population et chronicisation des maladies → demandent de prises en charge pluridisciplinaires
- Quelques défis à surmonter :

- La communication entre les professionnels
- La reconnaissance des rôles de chacun
- La formation à la coopération
- La charge de travail

I. Histoire de la profession médicale

Récapitulatif :

Les professions médicales se construisent sur la durée, avec des enjeux de régulation, d'encadrement de la formation puis de la profession, et de redéfinition des contours professionnels.

La régulation et l'encadrement se sont fait via des formations, des corporations puis les ordres professionnels, qui ont trois missions principales :
- Protéger la société des charlatans
- Garantir l'indépendance de la profession
- Défendre les intérêts de la profession

Le paysage des professions médicales et paramédicales est en perpétuelle redéfinition, les contours du périmètre d'intervention de chacun des corps professionnels n'est pas figé, il doit savoir s'adapter aux besoins de santé de la population, tandis que les interactions et la coordination entre les corps professionnels sont indispensables.

I. Histoire de la profession médicale

C. Régulation externe à la profession
Etude de cas : le scandale du sang contaminé

- Contexte : années 80 : épidémie de SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise)

- 1983 : premières alertes sur le risque de transmission du VIH par les transfusions sanguines. Aux USA : mise en place de mesures de dépistage

- 1984 : en France, même si le risque est connu, pas de généralisation de test pour le sang, produits sanguins non chauffé.

- 1985 : mise en place de tests. Environ 4000 personnes contaminées en France, dont de nombreux hémophiles.

- Conséquences : Nombreux décès.
- Poursuites judiciaires : accusations de négligence, procès (personnalités scientifiques et politiques).

I. Histoire de la profession médicale

C. Régulation externe à la profession
Etude de cas : le scandale du sang contaminé

- Bilan : lenteur de l'action, réformes et transformations sont nécessaires.

- Création de l'Agence française du sang en 1993 pour assurer une meilleure régulation des produits sanguins et garantir leur sécurité.

- Renforcement des protocoles de sécurité pour le dépistage des maladies transmissibles dans les dons de sang.

- Réforme de la politique de santé publique avec une plus grande prise en compte des principes de précaution et de transparence dans la gestion des risques sanitaires.

I. Histoire de la profession médicale

Etude de cas : le scandale du sang contaminé

- Besoin de renforcer les mécanismes de contrôle et de sécurité sur les produits de santé, y compris les médicaments.

→ Plusieurs agences sont créées. Par exemple : l'agence française du sang et l'agence du médicament.

- Mais de nouvelles affaires voient le jour : vache folle, hormone de croissance.

→ Encore de nouvelles agences sont créées : elles ont un périmètre défini (segmentation de l'expertise et de la gestion).

Certaines ont deux rôles de veille et de sécurité sanitaire, d'autres des rôles de gestion (ex : HAS).

I. Histoire de la profession médicale

D. L'hôpital comme espace de tension :

- L'hôpital a deux lignes d'autorités :

- La hiérarchie administrative, avec à sa tête un directeur d'hôpital : logique administrative.

- La profession médicale : système professionnel.

Exemple de tension : la tarification à l'activité (T2A) depuis 2003 :

Les informations sur les actes hospitaliers sont enregistrées dans une base de données, le PMSI, qui permet de fixer en partie le budget de chaque hôpital.

→ Modification du comportement des cliniciens.

II. Evolution des lieux de soin

1. Les premières missions de l'hôpital

- L'institution hospitalière existe depuis plus de 2000 ans, mais l'hôpital tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe que depuis cinq décennies.
- Première mission : assistance, charité, accueil des plus démunis (pas seulement les malades).
- Premiers hôpitaux : liés aux religions (ne pas apprendre la liste dans le détail) :

- Depuis -400 en Inde puis dans toute l'Asie : monastères pour accueillir les pèlerins
- A partir du IVe siècle (avènement du christianisme) : structures de charité pour les pauvres et les malades. Dans l'Empire romain byzantin : *xenodochium* et dans le monde musulman : *bimaristan*.
- A partir du Ve siècle en Europe : maison-dieu et hôtel-dieu, mais mauvaises conditions d'hygiènes.
- A partir du VIIIe siècle : développement des *hospitalia* pour accueillir et soigner les pèlerins (mais c'est le salut de l'âme qui domine).

II. Evolution des lieux de soin

2. Laïcisation des hôpitaux :

- A partir du XVIIe siècle : abandon progressif du modèle de l'hôtel-dieu. Les structures commencent à être gérées par l'Etat et deviennent laïques. Début des hôpitaux généraux : mais rôle asilaire plus que de soin.

→Période du « grand renfermement » décrite par Michel Foucault : l'hôpital a avant tout un rôle social : on y éloigne les vagabonds du reste de la cité.

→Les hôpitaux restent mal aimés : mauvaises conditions d'hygiènes, malades entassés dans les lits.



« Vous avez dans Paris un Hôtel-Dieu où règne une contagion éternelle, où des malades entassés les uns sur les autres se donnent réciproquement la peste et la mort. » (Voltaire, 1768)

L'Hôtel-Dieu de Paris brule en 1772, il est complètement détruit.

Hubert Robert, 1772.

II. Evolution des lieux de soin

3. Médicalisation des hôpitaux

- A partir du XVIIIe siècle, l'hôpital devient progressivement un lieu de soin, une « machine à traiter les malades » (Médecin et chirurgien Jacques Tenon). La fonction médicale devient plus importante que la fonction d'assistance, de salut ou d'éloignement. C'est bien la maladie qui devient le facteur d'hospitalisation.
- Les hôpitaux doivent devenir des **lieux de soin, de science et de formation**. Pour ce faire, il faut mettre fin à la promiscuité des malades d'une part, et à la fonction carcéral des établissements d'autre part. (Voir le cours sur la construction scientifique de la médecine : au cours du XIXe siècle, les sciences médicales s'élaborent au chevet du malade, mais aussi dans les salles d'autopsie et au laboratoire).

II. Evolution des lieux de soin

4. L'hôpital et la médecine clinique au XIXe siècle

- Médecins, architectes et hommes politiques cherchent à construire de nouveaux hôpitaux sur ces bases scientifiques. Quelques pistes:

- Séparer les hôpitaux pour nécessiteux des hôpitaux pour malades
- Faire des hôpitaux par spécialités
- Trier les malades par pathologie (pour éviter qu'ils ne se contaminent entre eux)
- Améliorer la circulation de l'air, augmenter le volume d'air autour d'un malade, améliorer les réseaux d'eau.

→ On pense que c'est le milieu qui rend malade (l'air vicié autour des malades). On pense aussi logiquement que changer le milieu aide à guérir. Il faut apporter aux malades un milieu plus sain.

II. Evolution des lieux de soin

4. L'hôpital et la médecine clinique au XIXe siècle

- Les théories médicales et l'architecture hospitalière évoluent conjointement.
- Rappel : méthode anatomoclinique : localiser le siège de la maladie et faire le lien entre lésions observées à la dissection et symptômes chez les malades.
- L'architecture doit soutenir le développement de cette méthode et permettre :

- De pratiquer les dissections
- De comparer de vastes séries de malades et d'enregistrer l'évolution des phénomènes pathologiques : en notant les entrées et les sorties, les contacts entre les malades, les transmissions dans l'hôpital…

- L'hôpital devient lieu de cure et de développement du savoir médical. Juxtaposition des chambres, salle de dissections, laboratoires et amphithéâtre encore en vigueur aujourd'hui.

II. Evolution des lieux de soin

5. L'hygiénisme puis les découvertes de Pasteur

- Principes de l'hygiénisme : évacuer l'air vicié, les miasmes. Donc : grand volume d'air et aération des salles. Mais : impossible à chauffer + trop de distances à parcourir pour les soignants.
- La découverte des micro-organismes invalide certaines thèses de l'hygiénisme.
- Il faut séparer les espaces et désinfecter.



II. Evolution des lieux de soin

6. L’architecture moderne du XXe siècle

- Architectes et médecins veulent favoriser des modes de vie jugés sains : lumière, soleil, plein air, nature, activités sportives…
- Naissance des sanatoriums + hybridation avec l’architecture hospitalière : création d’hôpitaux avec de grands balcons, jardins…
- Mais aussi : technicisation des hôpitaux : plateaux techniques, blocs opératoires, imageries médicales… deviennent le nouveau centre de gravité. Les soins bien faits doivent être réalisés « presque à la chaine ».
- Nouveaux défis : des hôpitaux techniques, mais aussi compacts, avec de plus en plus de chambres doubles ou individuelles (fin des dortoirs).





Exemples d’architectures hospitalières qui maximisent l’exposition au soleil et à l’air.
A gauche, sanatorium de Paimio, en Finlande, 1933
A droite, hôpital Louis Pasteur, Colmar, 1937

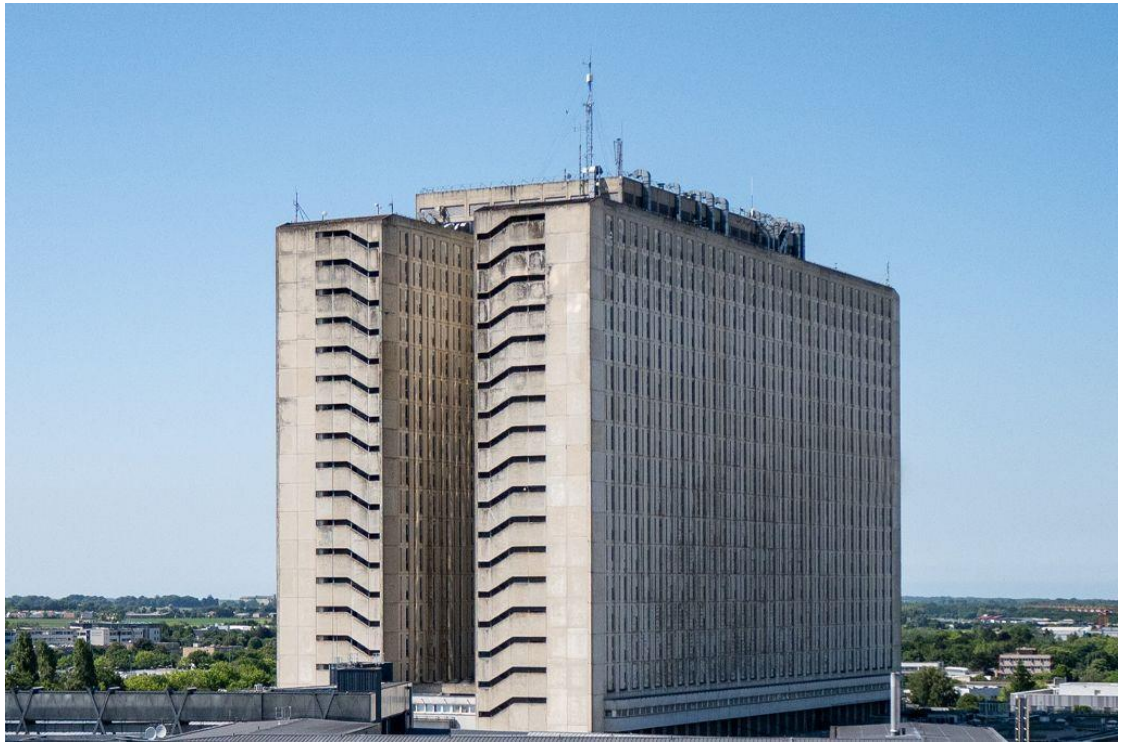
II. Evolution des lieux de soin

7. Création des hôpitaux universitaires

- Réforme Debré (loi hospitalière de 1958) créé les CHU : triple mission de soin, d'enseignement et de recherche.
- Hôpitaux en lien étroit avec les facultés de médecines : renforce l'assise scientifique de la médecine.



Hôpital Bichat, Paris, année 1980



CHU de Caen, années 1970

Transformations architecturales : des plateaux techniques de plus en plus vastes et centraux. Hôpitaux socle-tour (comme l'hôpital Bichat à Paris) ou monobloc (CHU de Caen).

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

1. Le travail invisible du malade

- Au cours du XIXe et du XXe siècle : le malade perd de sa centralité aux yeux du médecine : ce sont les lésions, puis l'infiniment petit qui intéressent le médecin. Le malade n'est que l'informateur du symptôme.
- Deuxième moitié du XXe siècle : le sociologue Strauss étudie « le travail invisible du malade », un travail nécessaire et attendu. Exemples : se laver, s'alimenter, se mesurer (glycémie), mais aussi réaliser certains gestes ou exercices douloureux mais essentiels pour les soignants… demande une culture médicale.

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

2. Vers une meilleure reconnaissance de la personne dans le soin

- Au cours du XXe siècle : le terme patient a progressivement remplacé celui de malade (qui vient du latin *male habitus*, qui signifie « en mauvais état »).
- Patient : du latin *patiens* (qui supporte, endure) et *patior* (souffrir, endurer, supporter) et surtout de l'anglais *patient*, renvoie à l'idée de « personne qui suit un traitement médical » et plus précisément à l'idée de dépendance vis-à-vis de l'institution biomédicale et du médecin.
- Mais aussi : nouvelle définition de la santé comme un état complet de bien-être, physique, psychique et social.
- On tente de réhumaniser la médecine et la personne, qui n'est pas seulement l'objet de l'investigation du médecin, mais qui a une histoire, des goûts, valeurs…

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

3. Emergence des associations de patients

- Un nouvel acteur à côté des médecins et de l'administration : les patients, organisés et représentés en associations.



Image du film *120 battements par minutes*, Romain Campillo, 2017

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

3. Emergence des associations de patients

- Notamment à partir de l'épidémie du SIDA (années 1980-1990). Elles visent à défendre les malades, par des rôles variés :

- Lutter contre la stigmatisation des malades
- Redonner une parole publique aux malades
- Soutien juridique, social, accompagnement des malades dans la vie quotidienne, etc.
- Informer les malades et le public sur la maladie, sa transmission et l'état de la recherche et des traitements. Vérifier et contrôler les informations diffusées dans les médias
- Peser sur le développement de traitements, obtenir des accès aux nouvelles molécules, améliorer les conditions des essais cliniques, etc.
- Politiser l'épidémie : elle ne touche pas tout le monde de la même manière, elle pèse le plus sur les populations vulnérables et marginalisées.

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

3. Développement de l'éducation thérapeutique

- ETP : éducation thérapeutique des patients. Se développe à la fin du XXe siècle à partir de deux bases :

- Faire passer des messages de santé et réduire la non-observance des traitements : pour faire adhérer les malades, mieux vaut coopérer.

- Emergence de la démocratie sanitaire :
  - A partir des années 1980, certains malades souhaitent faire valoir leurs connaissances et leur pouvoir de décision dans les traitements et les soins qui les concernent, mais aussi plus globalement, dans la recherche médicale ou dans les politiques de santé publique.
  - Ils sont les premiers à faire l'expérience de la maladie, ils peuvent être experts de leur maladie
  - Contre le paternalisme

→ La participation des malades à leurs soins, en coopération avec les soignants, devient plus courante et plus reconnue

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

3. Développement de l'éducation thérapeutique

- Le rôle des patients pairs (ou patients ressources, patients experts…) :

- Intermédiaire entre les malades et les soignants (quand la communication passe mal)
- Experts de la vie avec la maladie, peuvent donner des conseils, aider à articuler vie quotidienne et traitement, vie intime et maladie…
- Peuvent collaborer avec les soignants pour créer des programmes d'ETP, mais aussi participer à la démocratie interne à l'hôpital.

- Objectif : horizontaliser les relations entre patient et soignant, aider à ajuster la thérapeutique en lien avec la singularité du malade.
- Résultat : bouleversement des frontières de l'expertise.

III. La rôle croissant des patients dans le système de santé

4. Autres repères sur la démocratie sanitaire :

- Dans le droit européen, dès 1979, la promulgation de la « Charte européenne du malade usager de l'hôpital » témoigne d'un mouvement de reconnaissance des droits des patients dans le système de santé. La notion d'usager devient centrale dans les pays européens.
- En France, les États généraux de la santé ont été initiés par le gouvernement vers la fin des années 1990 pour confronter des jurys citoyens à des collèges d'experts et revaloriser la parole d'expérience face à la parole d'expertise.
- Les synthèses issues de ces manifestations ont inspiré les premiers travaux d'élaboration de la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, centrée sur la notion d'usager et de démocratie sanitaire. Aussi appelée Loi Kouchner. Instaure notamment la représentation des usagers, droit à l'information, accès au dossier médical, consentement éclairé…

Conclusion

Nous avons pu revenir sur les transformations de la formation médicale et les manières de pratiquer la médecine, en considérant également les lieux de cette pratique et la manière dont elle s'apprend, se transmet. Initialement, la médecine ne se fait pas à l'hôpital, ce n'est pas le lieu de travail des médecins. L'hôpital et les médecins restent ainsi séparés jusqu'au XVIIIe siècle.

L'hôpital est devenu un espace composé d'éléments technologiques, organisationnels, d'acteurs collectifs et individuels, qui interagissent avec une culture environnante dans laquelle entrent en jeu la formation scientifique, les transformations économiques de l'industrialisation ou encore les inégalités sociales.
Il devient tout à la fois le lieu emblématique de la médecine et du système de santé et un espace (social et architectural) aux contraintes multiples.

Les activités de soin sont régulées par les professions médicales, d'une part, mais également par des instances et dispositifs publics, d'autre part. De plus en plus, le patient, après avoir été relégué au second plan au cours du XIXe siècle, reprend une place centrale à la fin du XXe siècle. L'éthique du soin, le militantisme des malades et la démocratie sanitaire permettent aux malades d'être mieux pris en compte.

Le soin n'est pas uniquement laissé à l'appréciation des professionnels, il répond aussi à des enjeux politiques, économiques, sociaux et moraux.